



CHAPITRE 3. SÉMÉIOLOGIE PSYCHIATRIQUE

[Vassilis Kapsambelis](#)

in Vassilis Kapsambelis, Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l'adulte

Presses Universitaires de France | « [Quadrige](#) »

2012 | pages 41 à 60

ISBN 9782130572107

DOI 10.3917/puf.kapsa.2012.01.0041

Article disponible en ligne à l'adresse :

<https://www.cairn.info/manuel-de-psychiatrie-clinique-et-psychopathologi---page-41.htm>

Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.

© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Chapitre 3

Séméiologie psychiatrique

Vassilis Kapsambelis

La sémiologie psychiatrique est composée d'un vocabulaire de quelques centaines de termes, qui a été élaboré principalement par les psychiatries française et allemande au cours du XIX^e siècle et pendant les premières décennies du XX^e siècle (Bernard et Trouvé, 1977 ; Porot, 1984 ; Shahrokh et Hales, 2003). Comme en médecine en général, plusieurs de ces termes sont d'origine grecque (Kapsambelis, 1997). Ils obéissent souvent à une logique sémantique impliquant trois états : l'exagération d'une fonction ou expression (*hyper-*, *tachy-*, *poly-*), sa diminution (*hypo-*, *brady-*, *oligo-*) pouvant aller jusqu'à son extinction (*a-* privatif), ou enfin son exécution étrange, défectueuse, déformée ou incompréhensible (*dys-*, *para-*). Il s'agit donc de décrire des troubles « quantitatifs » et des troubles « qualitatifs ».

3.1. Examen psychiatrique et sémiologie

La sémiologie psychiatrique représente cette part de l'examen psychiatrique qui renvoie à un savoir ; elle lui tient donc lieu de connaissance objective, en l'absence de données issues d'examens paracliniques. Bien qu'empreinte de la subjectivité des deux protagonistes de la relation médecin-malade, elle fait l'objet d'un certain consensus et, empiriquement, on peut dire que deux psychiatres examinant à des moments différents (mais rapprochés) le même

patient retrouvent à peu près les mêmes éléments séméiologiques. De plus, elle a pour le patient une valeur de *reconnaissance* (Lantéri-Laura, 1973) : la souffrance décrite *existe*, elle a des mots pour elle, elle est dûment répertoriée par la science médicale.

Outre l'analyse séméiologique, l'examen en psychiatrie sera complété d'un relevé des antécédents, ainsi que d'un exposé biographique, au cours duquel plusieurs éléments seront évalués : conditions relatives à la naissance, maladies infantiles, contexte familial de l'enfance, scolarité et formation professionnelle, accès à la vie adulte : insertion sociale et professionnelle, vie affective et familiale.

Il existe un certain nombre de guides d'entretiens standardisés dits structurés ou semi-structurés qui, en association avec les échelles d'évaluation – qui, elles aussi, sont composées de listes de symptômes – permettent une meilleure « fidélité inter-juges » lors d'un examen psychiatrique (Guelfi, 1993, Guelfi *et al.*, 1995). En pratique, ces méthodes sont surtout utilisées en recherche, et le clinicien utilise une approche plus empirique, construite au fur et à mesure de son expérience à partir de sa formation initiale. Elle consiste à laisser au patient un temps de parole initial assez long, afin qu'il puisse exposer son problème tel qu'il le voit et le ressent ; puis le psychiatre complètera les éléments ainsi recueillis par des questions. Malgré l'empirisme de la méthode, et malgré l'existence de plusieurs courants théoriques au sein de la psychiatrie, le taux de concordance des diagnostics reste élevé, notamment pour les pathologies les plus graves et indiscutables.

En même temps, le psychiatre restera attentif à certaines caractéristiques propres aux signes cliniques qu'il relève. L'approche psychanalytique a montré le caractère symbolique des symptômes, compromis entre différents courants antagonistes de la vie psychique (Benoît et Daumézon, 1970) ; les symptômes « parlent » de l'histoire du patient, de ses rapports avec les autres, de ses désirs et aspirations contrariées, de ses réalisations et déceptions. Une attention particulière sera portée à l'*économie*, tout comme à la *temporalité*, des différentes manifestations pathologiques : dans quelle mesure envahissent-elles la vie du patient, dans quelle mesure parvient-il à les relativiser, à les discuter, à lutter contre ? Et aussi, depuis quand sont-elles présentes, connaissent-elles des fluctuations dans le temps, y a-t-il des circonstances qui les aggravent, ou au contraire qui les atténuent ?

3.2. Troubles des différents domaines de l'examen clinique

La séméiologie psychiatrique ne se laisse pas facilement présenter de façon rationnelle et incontestable. Néanmoins, on peut considérer que nous examinons les manifestations cliniques selon trois grands domaines : les fonctions cognitives (comprenant la perception, la pensée, la parole, le jugement, la mémoire...), les expressions affectives (émotions, affects) et les fonctions « exécutives », c'est-à-dire la volition (de la volonté jusqu'à réalisation, c'est-à-dire l'acte, la conduite, en passant par l'appareil – la psychomotricité – qui assure l'acte). À quoi s'ajoute la séméiologie des fonctions plus complexes (conscience, conscience de soi) et celle des fonctions physiologiques perturbées dans les pathologies mentales.

3.2.1. La présentation

La séméiologie de la présentation, appelée aussi d'« inspection », est très riche pour le psychiatre expérimenté et peut être relevée dès l'entrée du patient dans le bureau de la consultation, ou dès l'introduction chez lui, en visite à domicile (Faure, 1966). On remarquera la coiffure, la tenue vestimentaire, tout comme la tenue du lieu de vie. Le patient maniaque se montre débraillé, dans un univers tout en désordre, le patient schizophrène est habillé de façon étrange, excentrique, ou encore de façon très négligée au plan de l'hygiène corporelle et vestimentaire ; son intérieur est parfois empreint d'une désorganisation, d'un éparpillement, d'un aspect chaotique qui sont l'illustration même de l'incohérence qui règne dans son esprit. La comparaison entre un intérieur de patient maniaque et un intérieur de patient schizophrène est éloquente : sous des allures d'un même désordre apparent, on perçoit chez le premier un débordement vital incontrôlable, chez le second un aspect figé et mortifère.

D'autres éléments de la présentation sont rapidement visibles, comme les troubles de la psychomotricité et du langage (troubles de la communication, Lantéri-Laura, 1970).

3.2.2. Troubles du langage

Les troubles du langage font partie des éléments sémiologiques relevés rapidement lors de l'examen. Ils se divisent eux aussi selon leur aspect « quantitatif » (exagération ou diminution) ou « qualitatif ».

L'expression verbale connaît tous les stades de la diminution jusqu'à l'extinction, et son examen oriente utilement le diagnostic : par exemple, *inhibition* de l'expression verbale du patient déprimé, associée à un *ralentissement* plus général, psychomoteur et idéique. Le terme d'*alogie* désigne la pauvreté du discours, la *mussitation* les propos rares, proférés à voix basse et de façon indistincte. Le *mutisme* lui-même nécessite une analyse sémiologique soigneuse, à partir d'autres indications (anamnèse, expressions faciales, attitudes, contact visuel) : mutisme accablé du patient mélancolique, mutisme par méfiance du patient qui se sent menacé, mutisme par débordement émotionnel du patient en état traumatique, mutisme ludique du patient maniaque, mutisme dissocié du patient schizophrène en grande difficulté de pensée, mutisme hystérique. On observera aussi des manifestations comme le monologue, le soliloque, les dialogues hallucinatoires, les impulsions verbales. La *logorrhée* désigne une expression verbale abondante, incoercible, précipitée, qui caractérise tout état d'excitation psychique, et est caractéristique dans les états hyperthymiques. L'*écholalie* désigne la répétition automatique des mots et phrases de l'interlocuteur ; elle se rencontre dans la schizophrénie.

Les troubles qualitatifs du langage sont nombreux, et le plus souvent en rapport avec les troubles de la pensée propres aux pathologies schizophréniques à forte composante de désorganisation ; ils sont au cœur du *syndrome dissociatif* qui définit cette pathologie au sens de Bleuler (1911). La *palilalie*, devenue plus rare aujourd'hui, consiste en la répétition de syllabes, mots ou phrases (stéréotypies verbales). Les *néologismes* sont des mots inventés par le patient, chargés d'une signification personnelle et hermétique ; ils peuvent être composés à partir de mots existants, avec inversion de phonèmes. Autrefois, on pouvait observer des véritables paralangages (*glossolalie*), systèmes d'expression verbale propres au patient. Les *paralogismes*, plus fréquents, sont

des mots existants, utilisés par le patient hors de leur contexte sémantique (néologisme sémantique), réalisant parfois de véritables jeux de mots (« Je suis surveillé, il y a un télescope qui me télescope »).

Rappelons enfin que les troubles du langage peuvent être en rapport avec une souffrance neurologique (aphasie, agnosie).

3.2.3. Troubles de la pensée

On examinera ici les troubles du cours de la pensée, les troubles du contenu de la pensée, et les troubles du jugement.

Les troubles du cours de la pensée

Il peut être affecté dans le sens d'une accélération (*tachypsychie*) ou d'un ralentissement (*bradypsychie*) ; il réalise alors, soit des tableaux de profusion d'idées, pensées, souvenirs, exprimés de façon précipitée et avec de nombreux « coq-à-l'âne » (*fuite des idées*) soit au contraire un sentiment de pensée enlisée (*anidéisme*), confuse, floue. Les tachypsychies se rencontrent dans les états maniaques et, de façon générale, dans tout état hyperthymique qui s'accompagne d'un certain degré d'excitation. La bradypsychie est caractéristique chez le patient mélancolique, mais aussi confus ou dément.

Le cours de la pensée peut être affecté de façon caractéristique dans la schizophrénie : désorganisation (difffluence, incohérence, *ataxie*), relâchement, discontinuité et rupture des associations (*dissociation*), arrêts de la pensée (*barrages*), extinction progressive du déroulement de la pensée (*fading mental*). Associé aux troubles du contenu de la pensée, il réalise une pensée *déréelle*, illogique, ou encore abstraite, hermétique, détachée des objets concrets auxquels elle se réfère. Dans les cas extrêmes, le discours devient totalement incompréhensible (*schizophasie*).

Les troubles du contenu de la pensée

Ils comportent une riche séméiologie que l'on peut diviser en deux groupes, après les travaux d'analyse séméiologique des auteurs notamment français du XIX^e siècle :

1) Les troubles du contenu qui appartiennent à certaines des anciennes « *monomanies* » et qui, après l'introduction du critère de la conscience du caractère pathologique des troubles, rejoindront le groupe des névroses qui vient de se constituer à la fin du XIX^e siècle en tant que phobies, obsessions et idées fixes (Pitres et Régis, 1897 ; Janet, 1898, 1903).

Les *idées fixes* sont des pensées qui s'imposent à la conscience avec la volonté du sujet, car elles représentent une préoccupation majeure de son existence au moment où elles se produisent ; elles peuvent conduire à une pensée exclusivement orientée vers cette préoccupation (*monoiéisme*). Le terme d'idée fixe post-onirique désigne certaines idées qui sont apparues au moment d'une expérience hallucinatoire et délirante de type onirique, et qui persistent comme conviction après le décours de l'état pathologique, sans que cette conviction puisse être qualifiée de délirante.

Les *obsessions* représentent « l'irruption dans la pensée d'un sentiment, d'une idée, d'une tendance apparaissant au sujet comme un phénomène morbide, *en désaccord avec son Moi conscient*, qui émane pourtant de sa propre activité psychique et qui persiste malgré tous les efforts pour s'en débarrasser » (Pichot, 1961). On les classe en :

- a) *obsessions phobiques*, à savoir une crainte spécifique survenant en dehors de l'objet phobogène correspondant (par ex. nosophobie) ;
- b) *obsessions idéatives*, concernant une idée abstraite ou un mot (*onomatomanie*), un chiffre (*arithmomanie*), une décision à prendre (« *folie du doute* ») ;
- c) *obsessions impulsives*, à savoir idée et crainte de commettre un acte absurde, délictueux ou nuisible (« *phobie d'impulsion* »).

Les *phobies* sont des peurs paniques déclenchées par la mise en contact avec un objet ou situation précis (*objets phobogènes*).

2) Les *idées délirantes*. L'idée délirante est une conviction que le sujet ne partage pas avec d'autres personnes de même âge ou sexe, de même appartenance religieuse, culturelle ou politique, et qui s'impose à lui avec l'évidence d'une réalité irréfutable, se passant fondamentalement de preuves, même si le sujet consacre une partie de son activité mentale à en trouver, essentiellement pour pouvoir la

partager. Le terme de *délire* provient du latin *delirare* et signifie « dérailler », « perdre la raison », « divaguer ». En français, il existe un seul terme pour désigner ce symptôme, alors qu'en anglais, comme en allemand, il en existe deux : l'un désigne le fait de vivre des expériences hallucinatoires dans un état de conscience altérée (*delirium*), l'autre le fait d'avoir des idées erronées sur la réalité (angl. *delusion*, allem. *wahn*). La définition du délire au sens psychotique du terme est proche de celle donnée par Esquirol en 1814 (Lantéri-Laura et Tevissen, 1996) :

« Un homme est en délire lorsque ses sensations ne sont point en rapport avec les objets extérieurs, lorsque ses idées ne sont point en rapport avec ses sensations, lorsque ses jugements et ses déterminations ne sont point en rapport avec ses idées, lorsque ses idées, ses jugements, ses déterminations sont indépendants de sa volonté. »

Dans la tradition psychiatrique française, on décrit le délire selon cinq critères : les thèmes, les mécanismes, le degré de systématisation, de degré d'adhésion, la participation thymique et les troubles du comportement associés. Les *thèmes* sont multiples, résumant la totalité des passions humaines : l'amour et la haine, avant tout (thèmes persécutifs, érotiques, érotomaniaques, de jalousie...), mais aussi l'ambition et la place dans le monde (idées de grandeur, d'indignité), la métaphysique (thèmes religieux et mystiques, éternité, mort), l'influence d'autrui (idées de référence, d'influence). Les *mécanismes* utilisent les distorsions des perceptions (illusions, hallucinations), les distorsions du jugement (interprétations), les débordements imaginatifs (confabulations), les intuitions et l'automatisme mental. Le *degré de systématisation* étudie si l'expression des idées délirantes s'accompagne de troubles de la pensée formelle (incohérence, dissociation, constructions illogiques) ; il étudie donc la cohérence interne du discours délirant. La *participation thymique* s'intéresse aux états affectifs et émotionnels qui accompagnent les idées délirantes : le patient persécuté a-t-il des réactions de peur, d'attaque ou d'abattement ? Le délirant mystique se sent-il dans un état de transport et d'extase ? L'absence de congruence entre les idées délirantes et les expressions thymiques qui les accompagnent est appelée *discordance*, terme introduit par Chaslin (1912) et faisant partie des éléments séméiologiques fondamentaux de la schizophrénie, dans son opposition avec les psychoses délirantes chroniques systématisées. Enfin,

les *troubles du comportement associés* étudient les passages à l'acte, et le potentiel de passage à l'acte dans le cadre d'une élaboration délirante ; il s'agit d'un élément séméiologique de grande importance pour la psychiatrie légale.

Les troubles du jugement

Les troubles du jugement se rattachent traditionnellement aux états psychotiques, aigus ou chroniques. Les troubles passagers et réversibles du jugement font partie intégrante de l'expérience délirante et hallucinatoire aiguë, et aussi des épisodes confusionnels, pouvant entraîner des accidents graves, d'où la nécessité d'une surveillance particulière du patient en milieu hospitalier (fugue avec errance sans intention ou orientation précises, accidents domestiques). Les troubles durables du jugement s'associent aux syndromes délirants chroniques : il s'agit de distorsions du jugement conduisant à des *interprétations*, et plus généralement à des erreurs d'appréciation, l'appréhension de la réalité environnante étant soumise, pour le délirant, au postulat que constitue son idée délirante (*fausseté du jugement*). Minkowski (1927) a décrit le *rationalisme morbide*, discours rationnel froid, abstrait, pseudo-logique que l'on peut rencontrer dans la schizophrénie.

3.2.4. Troubles de la mémoire

La mémoire et l'oubli se trouvent au cœur du renouveau en psychopathologie apporté par les recherches sur l'hypnose, dans la seconde moitié du XIX^e siècle, qui ont abouti à la découverte de l'inconscient et à la théorie psychanalytique. Elles font également l'objet d'importantes recherches au niveau des sciences cognitives.

Traditionnellement, les *déficits mnésiques* (*amnésies*) se distinguent en *amnésies de fixation* et *amnésies d'évocation*. Les premières consistent en un défaut de mémorisation de nouvelles acquisitions ; le patient « oublie à mesure » les informations fournies. Elles sont appelées de ce fait « antérogades », dans la mesure où elles avancent avec le temps à partir de leur point de départ ; elles ne constituent donc pas un trouble de l'utilisation de la mémoire au sens du souvenir, mais

au sens de la création de nouveaux souvenirs. Les *amnésies d'évocation* sont des amnésies « rétrogrades », c'est-à-dire que, à partir du début des troubles, elles s'étendent progressivement en arrière dans le temps, de façon à ce que les souvenirs les plus récents soient les premiers affectés, et les souvenirs les plus anciens soient les mieux conservés. Les deux formes d'amnésie se combinent fréquemment dans la pratique clinique (*amnésie antéro-rétrograde* ou *mixte*). Notons aussi la *lacune amnésique* (oubli d'une période déterminée, ce qui est observé dans les pathologies traumatiques du système nerveux central ou les états confusionnels), les *amnésies électives* (proches du lapsus et de l'acte manqué), ainsi que les différents troubles de la mémoire en rapport avec la violence des émotions (pathologies traumatiques).

Les *proliférations mnésiques* sont observées sous certaines conditions exceptionnelles : *ecmnésies* (apparition brutale d'un souvenir vécu comme expérience actuelle), *hypermnésies* (accès soudain et massif à des souvenirs oubliés, qui peut se produire dans certaines crises d'épilepsie, ou lors d'un accident avec enjeu vital), *paramnésies* ou « illusions de la mémoire » (« faux souvenirs », comme dans la confabulation du syndrome de Korsakoff, sensations de « déjà-vu », « déjà-entendu », « déjà-vécu », que l'on peut rencontrer dans certaines crises épileptiques, mais aussi dans certaines pathologies schizophréniques, plus ou moins en rapport avec un automatisme mental).

Les recherches neurocognitives ont modifié la terminologie des fonctions mnésiques et de leurs troubles (Derouesné et Lacomblez, 2007). Les fonctions mnésiques se décomposent en trois temps : l'encodage (sélection et réception de nouvelles informations), le stockage (consolidation d'une partie de l'information encodée en vue d'une conservation), et la restitution (remémoration). On distingue la mémoire à court terme, ou mémoire de travail, qui traite une quantité limitée d'informations pour un temps limité (le temps nécessaire à son traitement), et la mémoire à long terme, d'une capacité et durée illimitées. La mémoire à long terme se subdivise en mémoire déclarative (directe, explicite) (souvenirs accessibles, évocation consciente) et en mémoire non déclarative (procédurale, indirecte, implicite). La mémoire déclarative comporte la mémoire épisodique (souvenirs d'événements) et la mémoire sémantique (langage, connaissances scolaires...). La mémoire non déclarative comporte la mémoire procédurale (mémorisation des habiletés perceptivo-

motrices et cognitives), le conditionnement, etc. À partir de ces subdivisions, plusieurs troubles mnésiques peuvent être décrits. Les déficits d'encodage sont liés aux troubles de l'attention ; les déficits de stockage sont ceux qui subissent l'érosion du temps ; les déficits des processus de rappel sont la cause la plus habituelle de l'oubli et se trouvent sous l'influence de multiples processus cognitifs. Les troubles mnésiques liés au processus de rappel sont fréquents dans les dépressions, alors que les déficits mnésiques dans les troubles anxieux sont plutôt en rapport avec des défaillances de la mémoire de travail, dues aux troubles de l'attention (distractibilité). Dans la schizophrénie, il y aurait atteinte de la mémoire de travail, déficit de la mémoire sémantique et diminution de la mémoire épisodique, avec conservation de la mémoire à court terme, de la mémoire procédurale et de la mémoire implicite.

3.2.5. Troubles de la perception

Les principaux troubles sont ici les *illusions* (perception d'un objet de façon déformée) et les *hallucinations*, classiquement décrites depuis Ball comme des « perceptions sans objet » (Brierre de Boismont, 1862), définition qu'Henri Ey (1973) a complétée comme « perception sans objet à percevoir », pour indiquer que l'hallucination n'est pas « sans objet », mais seulement que son objet n'est pas du domaine de la perception.

Les illusions et même les hallucinations sont relativement fréquentes, et sans valeur sémiologique univoque. On peut par exemple classer parmi les illusions les erreurs de lecture ou les illusions d'optique, les mirages, les impressions visuelles ou auditives de tout un chacun lors de certains moments affectifs particuliers (dans le noir, seul dans la rue, dans une ville inconnue, etc.). De même, des hallucinations peuvent se produire en rapport avec l'état de vigilance : hallucinations *hypnagogiques*, apparaissant pendant la période de l'endormissement, ou *hypnopompiques*, en période de réveil. Depuis Falret (1864), l'anosognosie (absence de conscience de l'état morbide) est un critère distinctif entre illusions ou hallucinations psychotiques et non psychotiques ; par exemple, certains patients épileptiques temporaires peuvent présenter des syndromes

hallucinatoires à long terme qui sont parfaitement reconnus par le patient comme pathologiques.

On appelle *synesthésie* l'impression que la perception sensorielle d'un organe de sens (par ex. vision) entre en résonance et s'accompagne d'une perception d'un autre organe de sens (par ex., audition, sensations tactiles). Ce type d'hallucinations se rencontre surtout dans les épisodes hallucinatoires aigus d'origine toxique.

Les hallucinations dominent les tableaux cliniques des psychoses aiguës, incluant les états oniroïdes et confusionnels, le *delirium tremens*, etc. Elles sont d'une autre qualité dans les psychoses chroniques, où elles se produisent en l'absence de tout trouble de la vigilance, et possèdent un caractère de ténacité et de répétitivité pathognomonique de ces affections. Baillarger (1846) est le premier à proposer une distinction entre hallucinations *psychiques* et *psychosensorielles* :

« Je crois qu'il y a lieu de distinguer deux sortes d'hallucinations, les unes complètes, composées de deux éléments et qui sont le résultat de la double action de l'imagination et des organes des sens : ce sont les hallucinations psychosensorielles ; les autres, dues seulement à l'exercice involontaire de la mémoire et de l'imagination, sont tout à fait étrangères aux organes des sens, elles manquent de l'élément sensoriel, et sont pour cela même incomplètes : ce sont les hallucinations psychiques. »

Les *hallucinations psychosensorielles* sont caractérisées par leur sensorialité et leur spatialité (« les voix viennent de tel endroit », « on les entend comme on vous entend parler »). Elles concernent donc les cinq organes de sens :

- Les *hallucinations auditives* comportent des bruits, des sons, des mélodies, des grincements, ou des voix (*hallucinations acoustico-verbales*), en rapport avec une parole intérieure que le sujet ne reconnaît pas comme sienne (Lagache, 1934). Elles ont un caractère souvent déplaisant, voire persécutif : injures, ordres, commentaires désagréables... Elles conditionnent des « attitudes d'écoute », parfois engagent le patient dans des « dialogues hallucinatoires » ou le conduisent à des mesures défensives (boules dans les oreilles).
- Les *hallucinations visuelles* (visions, apparitions...) sont très variées. Dans les psychoses chroniques, elles peuvent prendre la forme de visions terrifiantes ou étranges. Dans les pathologies impliquant une altération de la conscience et de la vigilance (confusions,

- delirium tremens*), on rencontre des *macropsies* (images agrandies), des *micropsies* (images réduites), des *zoopsies* à caractère effrayant.
- Les *hallucinations olfactives et gustatives* concernent des impressions de pourriture, d'âpreté, ou encore étaient des sentiments de menace (odeur de gaz).
 - Les *hallucinations tactiles* sont très fréquentes dans les états hallucinatoires avec altération de la vigilance (fourmillements, démangeaisons, variations de température). Elles peuvent aussi accompagner le syndrome de dépersonnalisation (sensation de bras ou de main « morte », froide et étrangère).

En dehors des hallucinations des cinq organes de sens, on observe également des *hallucinations cénesthésiques*, touchant la sensibilité commune (proprioceptive), sous forme de douleurs ou autres gênes corporelles (hypocondrie), de sensations génitales imposées, d'impressions de transformation corporelle, etc.

Les *hallucinations psychiques* sont des « voix intérieures », parfois rapportées comme des pensées étrangères au sujet et « répétées dans la tête » indépendamment de sa volonté, véritable phénomène « xénopathique », en ce sens qu'un étranger, un « autre », vient s'emparer de l'activité mentale du sujet. Elles réalisent certains syndromes caractéristiques (syndrome d'influence, syndrome d'automatisme mental) que nous examinerons au paragraphe 3.3.

Les hallucinations auditives et acoustico-verbales sont plus fréquentes chez les patients occidentaux, alors que les visuelles (et éventuellement cénesthésiques) prédominent chez les patients africains et asiatiques. Différentes études montrent que la prévalence des hallucinations visuelles a décliné en un siècle dans le monde occidental au profit des hallucinations auditives (Laroi *et al.*, 2008).

3.2.6. Troubles de l'expression affective et émotionnelle

La clinique des troubles de l'humeur, ou de la thymie, ou affectifs, a connu un développement considérable depuis les travaux de Kraepelin, pour représenter désormais une partie autonome de la nosographie psychiatrique (voir chapitre 30). Le terme d'*euthymie*,

peu utilisé, désigne une humeur stable, ou plutôt connaissant des variations restant dans les limites de la normalité. La *dysthymie* désigne dans la tradition psychiatrique française les fluctuations brutales de l'humeur, et en langue anglaise une humeur dépressive ne remplissant pas les critères d'un épisode dépressif. L'*hyperthymie* est un terme qui s'applique théoriquement à toute intensité excessive de l'humeur, mais il est plus souvent utilisé dans les états d'exaltation (manie, états passionnels, sthénicité). L'*euphorie* désigne une humeur exagérément expansive, voire exaltée (états maniaques); son contraire est l'affect dépressif (tristesse, morosité, « cafard », découragement...), et non pas la *dysphorie*, terme qui désigne plutôt une tristesse avec anxiété et irritabilité.

Plusieurs autres termes expriment différentes anomalies des affects et des émotions. L'*ambivalence*, dans son acception psychiatrique, est le terme utilisé par Bleuler (1911) pour désigner, dans la schizophrénie, l'impossibilité de synthèse entre sentiments d'amour et sentiments hostiles. L'*athymhormie*, terme forgé par Dide et Guiraud (Guiraud, 1956), exprime l'émoussement affectif (*athymie*) et la baisse de l'élan vital (*anhormie*) (voir chapitre 23, paragraphe 23.3.1). L'*anhédonie* désigne l'incapacité à éprouver du plaisir (Loas, 2002).

3.2.7. Troubles de la psychomotricité, de l'acte, des conduites et de la volonté

Nous regrouperons ici toute la séméiologie en rapport avec l'acte, l'*agir*. Elle concerne la psychomotricité, de ses manifestations les plus élémentaires jusqu'aux plus élaborés (actes et conduites), en passant par la volonté d'agir.

La *psychomotricité* va de l'agitation à l'immobilité, en passant par les gestes et mouvements étranges et incompréhensibles (Henry *et al.* 2006).

Très fréquente, l'*agitation* peut prendre plusieurs formes : *hypermie*, à savoir une vive expressivité faciale qui accompagne les contenus verbaux à caractère traumatique, passionnel, revendicatif, sexuel; mouvements incessants des mains et des yeux de l'anxieux; impossibilité de tenir en place du maniaque; colère et agressivité du patient qui se sent menacé; motricité désordonnée et perplexe du

confus ; stéréotypies et déambulations du patient schizophrène ; impulsivité imprévisible du patient halluciné ou désorganisé ; grande crise d'agitation avec décharge émotionnelle des situations de crise de toute origine ; *crise clastique* qui s'en prend aux objets dans une rage qui cache mal un sentiment d'impuissance. Le terme d'*impulsivité* s'associe à la notion de *passage à l'acte*, qui désigne un geste brutal, impérieux, obéissant à un besoin interne qui échappe au contrôle du sujet et qui est vécu dans un climat de tension qui cède aussitôt après l'accomplissement du geste ; il est associé à la suspension de toute activité d'élaboration mentale et de jugement, et peut avoir un caractère agressif ou incongru. Dans sa forme extrême, il s'agit d'un *raptus* anxieux, agressif ou suicidaire. On distingue le passage à l'acte de la *mise en acte*, qui désigne des conduites pathologiques plus complexes et élaborées, suivant un scénario conscient (bien que de détermination inconsciente), qui s'impose au sujet en tant qu'impulsion à laquelle il lui est difficile, voire impossible, de résister ; les mises en acte sont observées dans les pathologies perverses, dans certaines conduites répétitives de patients névrotiques ou états-limite, etc.

À l'opposé, l'entrave de l'expression psychomotrice est tout aussi caractéristique. L'*amimie* et l'*hypomimie* désignent l'absence ou la rarefaction de l'expressivité faciale (états dépressifs, schizophrénies, hystérie, états confusionnels). On remarquera la lenteur et l'inhibition psychomotrice (*bradykinésie*) qui, dans des formes extrêmes, peut aller jusqu'à sa suspension. On appelle *stupeur* un état d'apparition brutale, qui réalise une immobilisation totale des conduites motrices, observé dans certaines schizophrénies (stupeur catatonique), dépressions (stupeur mélancolique) ou états confusionnels. Il est à distinguer de la *cataplexie*, terme qui désigne également une immobilisation de la psychomotricité, mais d'une plus grande expressivité, laissant supposer que les attitudes figées renvoient à une forme de mise en acte : attitudes cataleptiques du patient schizophrène discordant, pris entre deux mouvements contraires qui s'équilibrent dans l'immobilité, attaques cataleptiques de l'hystérie, associées à d'autres manifestations pathologiques (attitudes d'extase, somnambulisme).

La psychomotricité peut enfin comporter des expressions étranges. L'*échopraxie* et l'*échomimie* désignent la répétition automatique des gestes et mimiques de l'interlocuteur. Les *paramimies* (ou dysmimies) désignent surtout des mimiques discordantes du patient schizophrène, mais aussi certains troubles factices. Les *parakinésies*

comportent l'ensemble des troubles du mouvement : stéréotypies motrices de la schizophrénie ou palikinésies (répétition mécanique du même mouvement), mais aussi des troubles en rapport avec les traitements neuroleptiques (dyskinésies, *tasikinésie*, que les patients désignent comme une « bougeotte », *akathisie* ou impossibilité de rester assis). Font partie des paramimies et parakinésies les *tics*, « mouvements involontaires, brusques et soudains, rapides et répétés. Ils atteignent des groupes de muscles en liaison fonctionnelle. Enfin, ils ont perdu toute utilité, s'ils pouvaient en avoir une à l'origine » (Lebovici, 1952). Notons enfin les nombreux troubles de la psychomotricité rencontrés dans l'hystérie de conversion (voir chapitre 19).

La clinique psychiatrique comporte diverses *conduites* pathologiques : tentative de suicide et suicide, conduites à risque, homicide, vol pathologique (kleptomanie), fugues, pyromanie... Certaines de ces manifestations sont traitées dans les chapitres correspondants. À l'inverse, la *volonté* peut être affectée au sens d'une *incapacité à passer l'acte* : l'*apragmatisme* désigne un état d'absence d'initiative, accompagné ou pas de velléités d'action qui restent à l'état de projets ; l'*aboulie* désigne l'absence de volonté.

3.2.8. Troubles de la vigilance, de l'attention, de la conscience, de la conscience de soi

Ces troubles, parfois à la limite de la neurologie et de la psychiatrie, sont globaux, ils se manifestent donc souvent en association avec d'autres troubles des fonctions examinées dans les chapitres précédents.

Les troubles de la vigilance renvoient à la fois aux différents stades du coma et aux états d'altération de la conscience que nous rencontrons dans certains états confusionnels (y compris hystériques), dans les traumatismes crâniens et autres agressions du système nerveux central, dans certains états psychotiques aigus, notamment d'origine toxique. Plusieurs termes désignent, selon les terminologies, des qualités différentes de cette atteinte de la vigilance et de la conscience (*rétrécissement* et *désagrégation du champ de la conscience*) : l'*obnubilation* (sorte d'engourdissement du fonctionnement

mental avec monoïdéisme), l'*obtusion* (défaut de compréhension avec ralentissement des opérations cognitives), l'*hébétude* (sidération des fonctions psychiques) (Lechevalier *et al.*, 1998). On observe ces différents degrés de diminution de la vigilance et de la conscience dans divers états (états crépusculaires, états seconds) plus ou moins rattachés à la clinique de l'hystérie ; en revanche, les états oniroïdes et l'onirisme sont en rapport avec la confusion mentale.

L'*hypervigilance* est observée dans certains états d'origine toxique (LSD, amphétamines), mais aussi dans les phases expansives de certaines psychoses chroniques (délire de persécution) et dans les états maniaques et hypomaniaques.

L'*attention* suit les mêmes variations que la vigilance ; on appelle *hypoproséxie* ou *aproséxie* la difficulté de concentration (distractivité, défaut de fixation de l'attention), et *hyperproséxie* l'état d'alerte que nous rencontrons chez les sujets anxieux, hyperémotifs, mais aussi délirants.

Le trouble de l'orientation dans le temps et dans l'espace (*désorientation temporo-spatiale*) accompagne souvent les troubles de la vigilance et caractérise essentiellement les états confusionnels et les démences.

Enfin, la *conscience de soi* peut connaître divers troubles, dont le plus fréquent est la dépersonnalisation (voir ci-dessous, paragraphe 3.3).

3.2.9. Troubles des fonctions physiologiques

Pratiquement toutes les grandes fonctions physiologiques (sexualité, alimentation-élimination, cycle veille-sommeil) peuvent se trouver perturbées dans tel ou tel aspect de leur fonctionnement dans le cadre des troubles mentaux.

Les troubles de la sexualité sont très fréquents, et touchent l'ensemble des pathologies. Ils peuvent être en rapport avec les médications psychotropes. L'impuissance, la frigidité, l'éjaculation précoce, la dyspareunie (vaginisme), sont très fréquentes, tout comme les pratiques masturbatoires. Les paraphilies (perversions sexuelles) sont examinées au chapitre 44.

Les troubles des conduites alimentaires sont également très fréquents. La restriction alimentaire volontaire (*anorexie*) constitue une entité clinique en soi lorsqu'elle s'accompagne d'un certain nombre d'éléments caractéristiques (voir chapitre 37). L'*hyporexie* et l'*anorexie*

ne sont pas rares chez les patients déprimés, ou chez les anxieux chroniques ; une anorexie avec perte de poids constitue un indice de dépression sévère. Un *refus alimentaire* peut être observé chez le patient mélancolique, persécuté ou schizophrène, en rapport avec des préoccupations délirantes. Inversement, l'*hyperorexie* se rencontre chez certains patients maniaques ; elle est à distinguer aussi bien de la *boulimie* (absorption impulsive d'une grande quantité de nourriture, suivie de sentiments de culpabilité et éventuellement de vomissements provoqués) que de la *polyphagie*, absorption habituelle d'importantes quantités de nourriture, observée chez les patients psychotiques, en rapport entre autres avec les traitements neuroleptiques. Le terme de *sitiomanie*, introduit par Magnan, correspond à la crise boulimique ; la *phagomanie* correspond au « grignotage » sans sensation de faim. D'autres troubles des conduites alimentaires peuvent être observés (gloutonnerie, voracité), notamment chez des patients psychotiques ; dans de grands états de régression, on peut observer une *coprophagie*. Enfin, l'absorption pathologique de liquides est décrite par deux termes : la *dipsomanie* est l'ingestion de grandes quantités de boissons alcoolisées de façon impulsive ; elle se rencontre chez des patients états-limite, plus rarement chez les maniaques. La *potomanie* est une ingestion compulsive d'eau ou de boissons non alcoolisées en grandes quantités, pouvant entraîner de graves troubles électrolytiques ; elle s'observe chez les patients schizophrènes, et elle est majorée par les neuroleptiques (sécheresse de la bouche) et le tabagisme.

Dans de grands états de régression psychotique, il n'est pas rare d'observer des troubles du contrôle sphinctérien (*énurésie*, *encoprésie*, « gâtisme schizophrénique »). L'énurésie se rencontre également dans l'alcoolisme.

Les troubles du sommeil, très fréquents dans toutes les pathologies mentales, sont examinés au chapitre 38.

3.3. Aspects syndromiques

Certains groupes de symptômes se présentent sous forme de syndromes caractéristiques, rencontrés tels quels dans certaines pathologies mentales.

Le *syndrome de référence* regroupe des idées délirantes à caractère interprétatif, des illusions et hallucinations auditives acoustico-verbales. Le sujet a le sentiment que ce qui se passe autour de lui se réfère à lui : un regard de passant dans la rue, la toux d'un inconnu dans le métro, tel propos ou image entendus ou vus à la télévision. Des mots ou phrases hallucinatoires (« regarde-le, celui-là ») peuvent venir compléter le tableau.

Le *syndrome d'influence* regroupe un certain nombre de symptômes (hallucinations sensorielles et psychiques, idées délirantes de persécution, troubles psychomoteurs, phénomènes télépathiques : pensée contrôlée et téléguidée...) qui signifient que la personne se sent sous l'emprise d'un autre, d'une force étrangère, contre laquelle il essaie de résister avec plus ou moins de succès, ou à laquelle il se trouve totalement soumis.

Le *syndrome d'automatisme mental* a été décrit par G. de Clérambault (1942) au cours des années 1910 et 1920. Il se présente comme une « scission du moi », ce dernier subissant un certain nombre de phénomènes élémentaires (pensées, images mentales...) qui échappent à son contrôle. On décrit le *petit automatisme mental* et le *triple automatisme mental*. Le petit automatisme mental comporte des pensées et souvenirs qui défilent de façon incoercible (*mentisme*, *ecmnésies*), des arrêts de la pensée, des phénomènes de dédoublement « mécanique » de la pensée (écho de la pensée), des commentaires de la pensée et des actes, des pensées « parasites ». Le triple automatisme mental concerne à la fois la sphère idéique, avec les phénomènes décrits précédemment, idéo-verbale (mots ou phrases prononcés contre la volonté du sujet), sensitive (sensations parasites), et psychomotrice (actes commis de façon « automatique » : agression, suicide..., le sujet se sentant dans une obligation inexplicable mais néanmoins impérieuse de les perpétrer).

La *dépersonnalisation* – *déréalisation* (Saladini et Luauté, 2003) est un syndrome qui peut se rencontrer dans diverses pathologies : hystérie, schizophrénie, épisodes délirants oniriques sous toxiques, mais aussi, sous une forme plus atténuée, dans la névrose obsessionnelle. Il se trouve au carrefour des conceptions neuropsychologiques, psychiatriques et psychanalytiques de la psychopathologie. Il touche à la notion de « schéma corporel », qui elle-même fait suite aux travaux neurologiques depuis la fin du XIX^e siècle sur la *somatognosie*, intégration des différentes sensations proprioceptives dans un

ensemble doté d'une unité, et d'un sentiment (d'une conscience) de son unité. Il concerne aussi la problématique des « limites du moi », et la différenciation entre « soi » et « non soi » (intérieur/extérieur, dedans/dehors, etc.). Cliniquement, il se présente comme un sentiment de *désappartenance* de telle ou telle partie ou tégument du corps ; il peut prendre l'allure d'une *désincarnation*, mais aussi d'une dissolution, transformation ou diffusion hors de l'enveloppe cutanée. Il peut concerner plus particulièrement le « moi psychique » (*désanimation*). Il s'accompagne d'un sentiment d'intense angoisse, ainsi que souvent d'une perte de familiarité avec les objets, l'environnement, l'ambiance habituelle du sujet (*déréalisation*).

Le *syndrome dissociatif* et la *discordance* sont deux termes qui, depuis Bleuler (1911) et Chaslin (1912), renvoient à la schizophrénie. Ils sont présentés au chapitre 23.

Conclusion

La séméiologie psychiatrique est à la psychiatrie clinique ce qu'est le solfège à la musique : elle permet de déchiffrer une partition, mais elle ne suffit pas pour assurer son interprétation. Le clinicien a tout intérêt à posséder une bonne connaissance de la séméiologie afin de ne pas laisser passer des éléments importants de la clinique de son patient qui, comme les patients somatiques, peut omettre d'évoquer des aspects de son mal qui sont essentiels pour sa compréhension. Mais, une fois ce déchiffrement correctement effectué, c'est aux deux protagonistes de s'en servir pour produire un travail psychique à deux qui, malgré sa part objectivable, sera marqué du sceau de l'originalité de leur rencontre.

BIBLIOGRAPHIE

- Baillarger M. J. (1846), *De l'influence de l'état intermédiaire à la veille et au sommeil sur la production et la marche des hallucinations*, Paris, J.-B. Baillière.
- Benoit G., Daumézon G. (1970), *Apport de la psychanalyse à la séméiologie psychiatrique*, Rapport au Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Paris, Masson.
- Bernard P., Trouvé S. (1977), *Séméiologie psychiatrique*, Paris, Masson.
- Bleuler E. (1911), *Dementia praecox ou Groupe des schizophrénies*, Paris, EPEL-GREG, 1993.

- Brierre de Boismont A. (1852), *Des hallucinations*, Paris, J.-B. Baillière.
- Chaslin P. (1912), *Éléments de sémiologie et clinique mentales*, Paris, Éditions Asselin et Houzeau.
- Clérambault G. de (1942), *Œuvres psychiatriques*, Paris, PUF.
- Derouesn  C., Lacomblez L. (2007), S miologie des troubles de la m moire, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37115-A10, Paris, Elsevier Masson.
- Ey H. (1973), *Tra t  des hallucinations*, 2 vol., Paris, Masson.
- Falret J.-P. (1864), *Des maladies mentales et des asiles d'ali n s*, Paris, J.-B. Bailli re.
- Faure H. (1966), *Les Objets dans la folie*, (t. I, *Hallucinations et r alit  p rceptive*, t. II, *Les Appartenances du d lirant*), Paris, PUF.
- Guelfi J.-D. (1993), *L' valuation clinique standardis e en psychiatrie*, 2 vol., Boulogne,  ditions m dicales Pierre Fabre.
- Guelfi J.-D., Gaillac V., Dardennes R. (1995), *Psychopathologie quantitative*, Paris, Masson.
- Guiraud P. (1956), *Psychiatrie clinique*, 3   d., Paris, Le Fran ois.
- Henry J.-M., V die C., Witjas T., Azulay J.-P., Poinso F. (2006), S miologie des troubles psychomoteurs, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37117-A10, Paris, Elsevier.
- Janet P. (1898), *N vroses et id es fixes*, Paris, Alcan.
- (1903), *Les Obsessions et la Psychasth nie*, Paris, Alcan.
- Kapsambelis V. (1997), *Termes psychiatriques fran ais d'origine grecque*, Paris, Masson.
- Lechevalier B., Eustache F., Viader F. (dir.) (1998), *La Conscience et ses troubles*, Bruxelles, De Boeck.
- Lagache D. (1934), «Les Hallucinations verbales et la parole», dans D. Lagache, *Œuvres*, t. I, p. 1-134, Paris, PUF, 1977.
- Lant ri-Laura G. (1970), Introduction   la pathologie de la communication, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37129-A10, Paris,  ditions techniques.
- (1973), Introduction g n rale   la s miologie en psychiatrie, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37101-A10, Paris,  ditions techniques.
- Lant ri-Laura G., Tevissen R. (1996), Historique des d lires chroniques et de la schizophr nie, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37281-C10, Paris, Masson Elsevier.
- Laroi F., Van der Linden M., Levaux M.-N. (2008), «Une approche cognitive de la schizophr nie», dans M. Van der Linden et G. Ceschi (dir.), *Tra t  de psychopathologie cognitive*, t. II, * tats psychopathologiques*, p. 225-248, Marseille,  ditions Solal.
- Lebovici S. (1952), *Les Tics chez l'enfant*, Paris, PUF.
- Loas G. (dir.) (2002), *L'Anh donie. L'insensibilit  au plaisir*, Paris,  ditions Doin.
- Minkowski E. (1927), *La Schizophr nie*, Paris, Payot.
- Pichot P. (1961), *Les N vroses*, Paris, Laboratoire de l'H patrol.
- Pitres A., R gis E. (1897), *S miologie des obsessions et id es fixes*, Bordeaux, Gounouilh .
- Porot M., Sutter J., P licier Y. (1984), *Manuel alphab tique de psychiatrie*, Paris, PUF.
- Saladini O., Luaut  J.-P. (2003), D personnalisation, *Encyclop die m dico-chirurgicale, Psychiatrie*, 37125-A10, Paris, Elsevier Masson.
- Shahrokh N. C., Hales R. E. (2003), *American Psychiatric Glossary*, 8   d., Washington, London, American psychiatric Pub.